

Traumatologie

Fascicule 12 · Fractures dentaires et atteintes des tissus mous (denture temporaire et permanente)

2 types d'atteintes : fractures (coronaire, corono-radriculaire, radriculaire) ET **atteintes des tissus mous** (intrusion, extrusion, luxation, expulsion). Traitement = dépend du type et de la maturité de la dent.

Fractures — arbre décisionnel

Fracture coronaire SANS exposition pulpaire

Indications : Limitée à l'émail/dentine, sans atteinte de la pulpe

Étape	Matériel
Traitement	Polissage (si très limitée) OU composite de restauration
Plateau	Plateau OCR (turbine · CA bague rouge/bleue · composite · adhésif · lampe à polymériser · fraises diamantées grains fins · cupules à polir)

Fracture coronaire AVEC exposition pulpaire

Indications : La pulpe est exposée — réaction selon maturité de la dent

Étape	Matériel
Dent mature	Coiffage direct (effraction limitée) OU pulpotomie / traitement endo (effraction étendue)
Dent immature	Apexogénèse (pulpe vivante à préserver pour fin d'édification) OU apexification (pulpe nécrosée)
Plateau	Plateau OCE (digue · CA bague bleue · limes endo · irrigation hypochlorite · biomatériau ou hydroxyde de calcium · gutta + ciment de scellement)

Fracture corono-radriculaire

Indications : Selon le trait de fracture et la communication avec le milieu buccal

Étape	Matériel
Sans exposition pulpaire	Extraction du fragment mobile
Avec exposition pulpaire	Avulsion OU extrusion ortho ou chirurgicale pour conservation

Fracture radiculaire

Indications : Selon le niveau du trait et la distance entre les fragments

Étape	Matériel
1/3 coronaire	Traitement endo + prothèse · contention · surveillance vitalité pulpaire
1/3 médian	Extraction · contention · surveillance vitalité pulpaire
1/3 apical	Apicectomie + traitement endo · contention + surveillance vitalité pulpaire

Atteintes des tissus mous — arbre décisionnel

Intrusion

Indications : La dent est enfoncée dans l'alvéole

Étape	Matériel
Option 1	Ré-éruption spontanée possible (surveillance)
Option 2	Repositionnement orthodontique ou chirurgical
Suite	Surveillance régulière

Extrusion / Luxation

Indications : La dent est sortie ou déplacée de son alvéole sans expulsion

Étape	Matériel
Traitement	Repositionnement + contention
Suite	Surveillance régulière

Expulsion (avulsion traumatique)

Indications : La dent est totalement sortie de l'alvéole — pronostic dépend du Temps Extra-Alvéolaire (TEA)

Étape	Matériel
TEA < 60 min + milieu adéquat (sérum, lait, salive)	Réimplantation + contention · surveillance régulière
TEA > 60 min OU milieu inadéquat	Traitement endo + réimplantation
Plateau	Sérum physiologique stérile · digue · contention (fil + composite OU attelle) · matériel d'endo si TEA > 60 min

Conseils au patient (TEA) : ne jamais nettoyer la dent (préserver le ligament). Conserver dans : **sérum physiologique** → **lait** → **salive du patient**. Consulter en urgence : pronostic excellent si réimplantation rapide.

Rôle de l'AD en traumatologie

Accueillir l'urgence · rassurer le patient (et les parents si enfant) · préparer le plateau adapté · aspirer · préparer la radio · appliquer les conseils post-trauma (alimentation molle, hygiène douce, surveillance de la couleur de la dent dans les semaines suivantes).